

PAUSE CARDIO

Nouveautés de la semaine du 12 septembre 2026

7 nouveautés cette semaine, dont 1 susceptible de changer votre pratique.

PRÉVENTION **Changement de pratique** Essai randomisé · Lp(a)HORIZON

Novartis announces Lp(a)HORIZON Phase III topline results for pelacarsen in patients with elevated Lp(a) and established cardiovascular disease (CVD)

Communiqué Novartis · 4 septembre 2026 · Essai randomisé de phase 3, résultats principaux annoncés avant présentation en congrès

Chez 8 323 patients ayant une maladie cardiovasculaire établie et une lipoprotéine(a) élevée (≥ 70 mg/dL), le pelacarsen, oligonucléotide antisens qui bloque la production de la Lp(a) à sa source, a été comparé au placebo en double aveugle. Le laboratoire annonce que le critère principal composite (décès cardiovasculaire, infarctus non fatal, AVC non fatal, revascularisation coronaire urgente avec hospitalisation) n'a pas été atteint, alors que le traitement abaissait bien la Lp(a). Aucun taux d'événements ni rapport de risques n'a été communiqué : les résultats complets seront présentés lors d'un prochain congrès.

En pratique : ce premier essai de morbi-mortalité ciblant la Lp(a) est négatif sur son critère principal, ce qui fragilise l'hypothèse selon laquelle abaisser la Lp(a) suffirait à réduire les événements chez le patient en prévention secondaire bien traité par ailleurs. Rien ne change pour l'instant dans la prise en charge : la Lp(a) reste un marqueur de risque (les recommandations européennes en conseillent un dosage au moins une fois dans la vie), et les décisions se prennent sur les facteurs de risque modifiables. Les résultats détaillés et les autres essais en cours diront si une population ou un degré de baisse particuliers en tirent bénéfice.

[Article original](#) · [Analyse TCTMD](#)

PRÉVENTION **À connaître** Essai randomisé · TARGET-D

Targeted vitamin D supplementation and major adverse cardiovascular events after myocardial infarction: the TARGET-D trial.

European Heart Journal · 7 septembre 2026 · Essai randomisé pragmatique, 630 patients

Chez 630 patients ayant présenté un infarctus du myocarde, une supplémentation en vitamine D3 ajustée pour maintenir un taux de 25-hydroxyvitamine D entre 40 et 80 ng/mL a été comparée aux soins habituels, avec un suivi moyen de 4,2 ans. Le critère principal (décès, infarctus, hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou AVC) est survenu chez 15,7 % des patients supplémentés contre 18,4 % dans le groupe témoin, différence non significative. La baisse des infarctus observée parmi les critères secondaires reste un signal exploratoire.

En pratique : même ajustée à un taux cible, la supplémentation en vitamine D n'a pas démontré de réduction des événements cardiovasculaires après infarctus. L'étude ne justifie donc pas de prescrire de la vitamine D dans un but de prévention cardiovasculaire après infarctus. Le signal sur les infarctus mérite d'être testé dans un essai plus large avant d'en tirer quoi que ce soit.

[Article original](#)

Clinical Considerations for the Care of the Tactical Athlete With Cardiovascular Abnormalities: A Scientific Statement From the American College of Cardiology and the American Heart Association.

JACC · 3 septembre 2026 · Déclaration scientifique ACC/AHA

L'American College of Cardiology et l'American Heart Association publient une déclaration scientifique consacrée à l'« athlète tactique », c'est-à-dire le pompier, le policier ou le militaire porteur d'une cardiopathie ou à risque cardiovasculaire. Organisée en onze sections, elle propose pour chaque situation (cardiomyopathies génétiques, myocardite, cardiopathies congénitales, aortopathies, syncope et arythmies, canalopathies, sujet âgé, expositions environnementales) des tableaux de « considérations cliniques » qui tiennent compte des exigences du métier et des conséquences d'un événement cardiaque sur les coéquipiers et la mission.

En pratique : un document utile au cardiologue sollicité pour un avis d'aptitude chez un pompier, un policier ou un militaire porteur d'une cardiomyopathie, d'une canalopathie, d'une aortopathie ou d'antécédents de myocardite ou de syncope. Il fournit un raisonnement structuré, par type de tâche et par pathologie, là où les recommandations sur le sport de compétition ne répondent qu'en partie. Les décisions restent individuelles et s'inscrivent dans le cadre réglementaire propre à chaque corps.

[Article original](#)

Infective Endocarditis: Diagnosis, Antibiotic Therapy, and Management: A Scientific Statement From the American Heart Association.

Circulation · 8 septembre 2026 · Déclaration scientifique de l'American Heart Association, mise à jour du document de 2015

Onze ans après sa déclaration de 2015, l'American Heart Association actualise sa position sur l'endocardite infectieuse, dont l'incidence a augmenté et l'épidémiologie a changé. Le document intègre les nouvelles définitions de cas, l'identification des germes sans culture, l'imagerie multimodale, l'essai randomisé de relais oral publié en 2019, l'aspiration mécanique percutanée des végétations droites chez des patients sélectionnés dont l'infection n'est pas contrôlée, et l'importance de l'équipe d'endocardite.

En pratique : une mise à jour de référence à garder pour les situations d'endocardite où la conduite n'est pas évidente : place du relais oral partiel, apport de l'imagerie multimodale, recours à l'aspiration percutanée des végétations droites quand l'infection n'est pas contrôlée. Elle complète, sans les remplacer, les recommandations européennes de 2023, et rappelle l'importance d'une équipe d'endocardite.

[Article original](#)

An Updated Evidence Assessment of the Genetic Causes of Dilated Cardiomyopathy.

Circulation · 8 septembre 2026 · Réévaluation par le groupe d'experts ClinGen (Clinical Genome Resource), 68 gènes

Le groupe d'experts du Clinical Genome Resource (ClinGen) consacré à la cardiomyopathie dilatée a réévalué en 2024–2025 la validité clinique de 68 gènes, soit 72 relations gène–maladie–mode de transmission. Trente-cinq relations atteignent un niveau de preuve élevé (16 définitives, 10 fortes, 9 modérées), contre 19 lors de l'évaluation de 2019–2020, avec neuf nouveaux gènes solidement établis et douze relations de transmission autosomique récessive. Vingt-neuf relations restent à preuve limitée, et quatre gènes sont sans lien démontré avec la maladie.

En pratique : ce référentiel actualisé sert à lire un compte rendu de test génétique dans la cardiomyopathie dilatée : un variant dans l'une des 35 relations gène–maladie à preuve élevée n'a pas le même poids qu'un variant dans un gène à preuve limitée, à interpréter avec beaucoup plus de réserve. Il peut aussi inviter à relire d'anciens résultats négatifs ou incertains, puisque plusieurs gènes ont changé de statut depuis 2019–2020. L'interprétation reste l'affaire d'une consultation de génétique cardiovasculaire.

[Article original](#)

Myeloperoxidase inhibition with mitiperstat in heart failure with preserved or mildly reduced ejection fraction: a randomized phase 2b trial.

Nature Medicine · 9 septembre 2026 · Essai randomisé de phase 2b, 711 patients

Chez 711 patients insuffisants cardiaques à FEVG supérieure à 40 % (45 % de femmes), le mitiperstat, inhibiteur de la myéloperoxydase, a été comparé au placebo à deux doses pendant 48 semaines, dans un essai multicentrique en double aveugle. À 16 semaines, il n'a amélioré ni le score de symptômes KCCQ (différence -1,4 point ; IC95 % -3,9 à 1,2) ni la distance de marche en six minutes (+3,8 m ; IC95 % -3,1 à 10,8), ni aucun critère secondaire. La tolérance était comparable au placebo, en dehors d'éruptions maculopapuleuses plus fréquentes.

En pratique : un essai négatif pour une approche anti-oxydante ciblant la myéloperoxydase dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée ou modérément réduite. Le mitiperstat n'a apporté aucun bénéfice symptomatique ou fonctionnel à quatre mois, malgré une bonne tolérance. Rien ne change dans la prise en charge de ces patients, qui repose sur les traitements ayant fait leurs preuves.

[Article original](#)**Exercise stress echocardiography for diagnosis of heart failure with preserved ejection fraction: a multicentre study.**

European Heart Journal · 10 septembre 2026 · Étude diagnostique, 482 patients, avec cohorte de validation internationale

Chez 482 patients explorés pour une dyspnée chronique inexpliquée par cathétérisme d'effort avec échocardiographie simultanée (386 insuffisances cardiaques à FEVG préservée, 96 dyspnées non cardiaques), les scores diagnostiques actuels associés à l'écho d'effort n'ont détecté la maladie qu'avec une sensibilité de 55 à 60 %. L'ajout de la compliance atriale gauche de repos (strain réservoir divisé par E/e') avec des seuils distincts pour affirmer et pour écarter le diagnostic porte la sensibilité à 95–99 % chez les patients classés, et réduit d'environ 60 % à environ 30 % la part des patients nécessitant un cathétérisme d'effort. Ces résultats ont été reproduits dans une cohorte de validation internationale.

En pratique : devant une dyspnée inexpliquée à FEVG préservée, l'écho d'effort utilisée comme aujourd'hui laisse passer environ quatre cas sur dix : un résultat normal n'écarter pas la maladie. Mesurer le strain de l'oreillette gauche au repos et appliquer des seuils séparés pour affirmer et pour écarter le diagnostic permettrait de conclure sans cathétérisme chez plus de patients, en réservant l'exploration invasive aux cas indéterminés. Ces seuils demandent à être adoptés dans les recommandations avant de devenir la règle.

[Article original](#)